

TEMA 2.23 • DIABETES Y DISLIPIDEMIAS

Miopatías por Estatinas

PERFIL EUNACOM 1.04.1.021

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Miopatía por Estatinas

Las estatinas son seguras y eficaces, pero tienen riesgo de efectos adversos musculares. Son relativamente infrecuentes pero importantes de reconocer.

Tipos de Miopatía por Estatinas

TABLA 2.23.1: TIPO VS CLÍNICA			
TIPO	CLÍNICA	CK	CONDUCTA
Mialgia / No severa	Dolor muscular, debilidad leve.	Normal o levemente elevada	Buscar causa alternativa → suspender si se confirma → reiniciar con estatina diferente
Rabdomiólisis	Dolor muscular intenso, orina oscura (mioglobinuria), falla renal aguda	Muy elevada	Suspender DEFINITIVAMENTE. Tratar falla renal (hidratación agresiva).
Miopatía inmunomediada por estatinas	Debilidad proximal severa, progresiva incluso al suspender el fármaco	Muy elevada	Suspender DEFINITIVAMENTE. Tratar con corticoides EV.

Algoritmo de Manejo en Miopatía No Severa

- **Buscar causas alternativas** antes de culpar a la estatina:
 - - TSH (**hipotiroidismo** → miopatía frecuente)
 - - Vitamina D (déficit → mialgias)
- **Suspender estatina** → Ver si los síntomas desaparecen. Si no desaparecen → la causa NO era la estatina.
- **Reiniciar con estatina diferente** de menor riesgo miopático:
 - - Fluvastatina, Pravastatina, Pitavastatina (menor riesgo de mialgias, pero menos potentes para bajar LDL)
 - - Alternativa: Misma estatina en dosis reducida
- **Si recurrencia:** Suspender definitivamente → reemplazar por **Ezetimibe**.

Control de CK en Pacientes con Estatinas

- **Sin síntomas:** No pedir CK de rutina.
- **Con síntomas musculares o falla renal:** Sí pedir CK.
- Es útil pedir CK **basal previo** al inicio del tratamiento como referencia comparativa.

Interacción Estatinas + Fibratos

TABLA 2.23.2: COMBINACIÓN VS RIESGO	
COMBINACIÓN	RIESGO
Estatina + Gemfibrozilo	Contraindicado — Riesgo grave de rabdomiólisis

| Estatina + **Fenofibrato** | Se puede usar con precaución (solo en hipertrigliceridemia severa + LDL elevado simultáneamente) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 65 años en tratamiento con simvastatina 40 mg consulta por dolor muscular difuso. CK sérica normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Miopatías por Estatinas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las mialgias son el efecto adverso más frecuente de las estatinas (5-10%)
- El espectro va de mialgias simples a miositis a rabdomiolisis
- La rabdomiolisis cursa con CK >10.000, mioglobinuria e IRA
- Hipotiroidismo no tratado es un factor de riesgo importante para miopatía
- Simvastatina y lovastatina tienen mayor riesgo de interacciones (CYP3A4)
- Pravastatina y rosuvastatina tienen menor riesgo de miopatía
- No combinar gemfibrozilo con estatinas (alto riesgo de rabdomiolisis)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MIOPATÍAS POR ESTATINAS)

PREGUNTA 1

Paciente de 65 años en tratamiento con simvastatina 40 mg consulta por dolor muscular difuso. CK sérica normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ A) Suspender estatina definitivamente
- ☐ B) Reducir dosis o cambiar a otra estatina como rosuvastatina
- ☐ C) Agregar gemfibrozilo
- ☐ D) Solicitar biopsia muscular
- ☐ E) Mantener tratamiento sin cambios

PREGUNTA 2

Paciente en tratamiento con atorvastatina desarrolla dolor muscular severo con CK de 15.000 U/L y orina oscura. ¿Diagnóstico y conducta?

- ☐ A) Miositis leve, reducir dosis
- ☐ B) Rabdomiolisis, suspender estatina e hidratar agresivamente
- ☐ C) Mialgias simples, cambiar de estatina
- ☐ D) Miositis, agregar coenzima Q10
- ☐ E) Continuar estatina y controlar CK en 1 semana

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes factores aumenta significativamente el riesgo de miopatía por estatinas?

- ☐ A) Hipertiroidismo
- ☐ B) Hipotiroidismo no tratado
- ☐ C) Uso concomitante de ezetimibe
- ☐ D) Obesidad
- ☐ E) Uso de paracetamol

RESUMEN: MIOPATÍAS POR ESTATINAS

Las miopatías por estatinas son el efecto adverso más frecuente y clínicamente relevante de estos fármacos, afectando al 5-10% de los usuarios. El espectro clínico va desde mialgias simples (dolor muscular sin elevación de CK), pasando por miositis (dolor con CK elevada más de 10 veces sobre el límite normal), hasta rabdomiolisis (destrucción muscular masiva con CK mayor a 10.000, mioglobulinuria, insuficiencia renal aguda y riesgo vital). Los factores de riesgo para miopatía incluyen edad avanzada, sexo femenino, masa corporal baja, hipotiroidismo no tratado, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, interacciones farmacológicas (especialmente con inhibidores de CYP3A4 como macrólidos, antifúngicos azólicos, gemfibrozilo), consumo excesivo de alcohol y uso de dosis altas de estatinas. La simvastatina y lovastatina son las que más se metabolizan por CYP3A4 y tienen mayor riesgo de interacciones. El manejo depende de la severidad. En mialgias leves con CK normal, se puede intentar reducir dosis, cambiar de estatina (pravastatina y rosuvastatina tienen menor riesgo) o usar régimen intermitente. En miositis con CK elevada más de 10 veces, suspender la estatina. En rabdomiolisis, suspender estatina, hidratación agresiva y manejo en UCI. Se puede reintentar con otra estatina a dosis baja cuando la CK se normalice. La coenzima Q10 tiene evidencia limitada pero se usa frecuentemente.